看板 档案 A · 患者本人视角 | 记录者随条目标注 | 构建 2026-10-25 | v0.1.0

档案

慢性期（CP） | 转录本 e14a2（典型）

姓名	周建国
性别 / 年龄	男 / 46 岁
概况	CML 慢性期 · e14a2 转录本 · 设备售后工程师
医生告知的分层	ELTS 中危（医生告知）
一句话病史	2026-01 体检发现白细胞升高确诊慢性期 CML（e14a2），伊马替尼 400mg 起步，8 月因胸腔积液换达沙替尼 50mg
本人最在意的	最怕"停药"两个字听不懂：医生说过 MMR，但报告上到底哪一行是医生要看的，我记不住
本页记录者	本人

今日服药卡

达沙替尼 50 mg 每日 | 本机打卡

今天还没记。

今天吃了吗 | 一键已服 | 标记漏服 | 模拟本地写失败 | 去服药线

最近 3 天

2026-10-12
已服 记录者：本人

2026-10-11
已服 记录者：本人

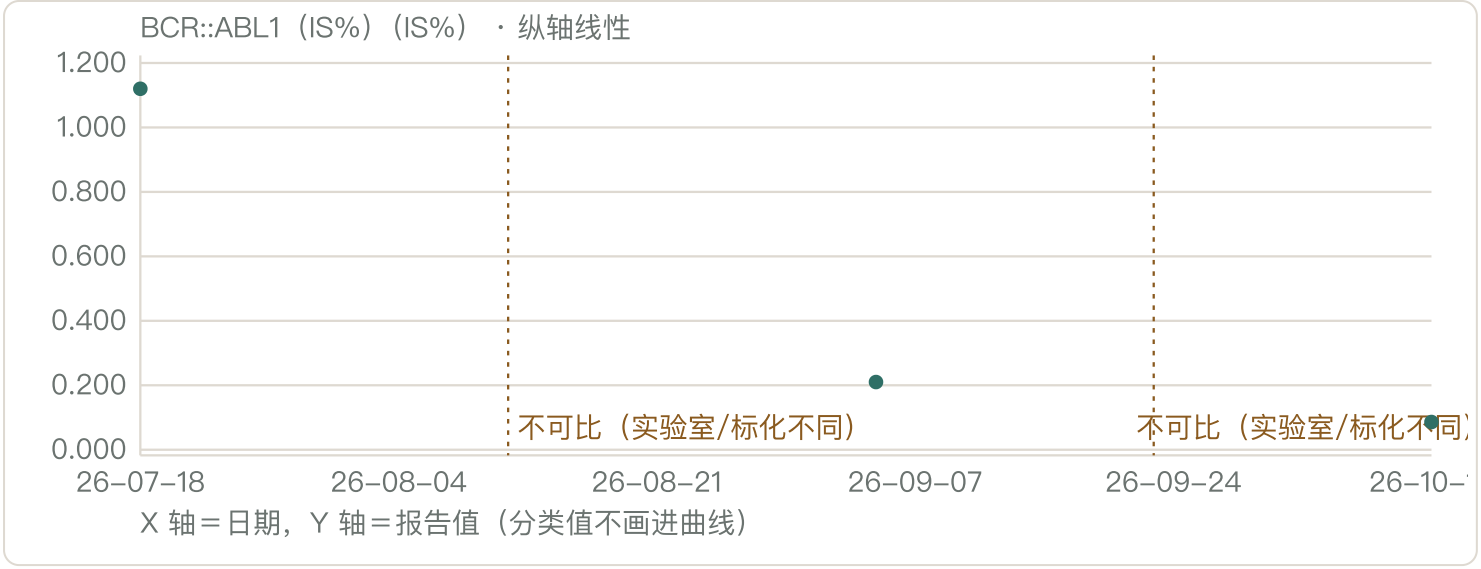
2026-10-10
漏服 记录者：本人

漏服不评判；补服分支规则与来源见服药线「今日打卡」。

分子线速览（最近 3 点）

距下次复查 约 3 个月

日期	BCR::ABL1（IS%）	实验室	IS 标化	灵敏度
2026-07-18	1.120	省血液病医院	是	MR4.5
2026-09-05	0.210	外院（华山医院）	否	未注明
2026-10-12	0.086	省血液病医院	是	MR4.5



四要素（单位 / 实验室 / IS 标化 / 灵敏度）在分子线页逐点列出；相邻点不可比时断开折线。

记一笔复查　去分子线　病情一图秀（叠看几条线）

下次复查安排：BCR::ABL1 qPCR · 每 3 个月（12 个月里程碑后） · 2027-01 中旬（医生安排，仅照抄）

副作用速记（按当前用药过滤）

当前：达沙替尼 50 mg 每日　已隐藏 3 条非当前用药条目

2026-09-02
胸腔积液 / 气促　dasatinib　记录者：本人
爬两层楼就喘，躺下更明显

2026-09-28
（示例）夜里睡不好　dasatinib　记录者：本人　私密
躺下想事情，担心拖累家里

记一次不舒服　去副作用日志

只记录不适与处理原文，不出现严重度判读列。

费用速记（按月 × 按药）

不跨药混算　本机新增 0 笔

最近一月（2026-10）自费合计	620 元
全部月份自费合计	3530 元
已记条目数	7 条

只照抄票据金额，不做省不省钱判断。

记一笔　去费用记录

复诊倒计时

2026-10-13

事项	频率 / 书面口径原文	依据	下次时间
血液科门诊	每 3 个月 来源：医生安排（照抄）	医生安排	2027-01 上旬

事项	频率 / 书面口径原文	依据	下次时间
BCR::ABL1 qPCR	每 3 个月（12 个月里程碑后） 来源：医生安排（照抄）	医生安排	2027-01 中旬
血常规	每月 1 次（血象稳定后） 来源：医生安排（照抄）	医生安排	2026-11 上旬

准备复诊（生成资料包与问题清单）　AI 协助（示例） · 复诊准备：整理资料包大纲

值得报告的信号（HVT-11）

来源未核验　静态事实清单

信号（来源原文口径）	来源	版本	状态
发热：体温 ≥38.3 ℃，或 ≥38 ℃ 持续 1 小时以上	中国 CML 诊疗指南（2025 版）· 感染与支持治疗章节	GL-CN-2025	未核验
新发或加重的骨痛 / 关节痛	中国 CML 诊疗指南（2025 版）· 随访章节	GL-CN-2025	未核验
气促 / 呼吸困难 / 静息时也不缓解	中国 CML 诊疗指南（2025 版）· TKI 不良反应章节	GL-CN-2025	未核验
皮肤或黏膜出血点、牙龈出血不易止	中国 CML 诊疗指南（2025 版）· 血液学监测章节	GL-CN-2025	未核验

> 本卡不做个体判断，不给是否就医结论；是否联系医生由你与医生决定。来源未核实 → 标「未核验」。

空态（无信号记录时）：还没有记录信号，卡片只显示上面这份来源清单。

本页 AI 协助

点击后派发 `cml:agent-draft`，提示词只进会话区输入框，不自动发送。

AI 协助（示例）　分子线　TFR 档案　资料导入

手工入口与通道

… 更多

资料导入（候选 → 核对）与临床试验（M4 数据未接入）从本卡「… 更多」和「准备复诊」路径进入。